FEEDBACK – Réanalyser la vidéo « Un bon entretien » sous l'angle du contenu exploré

Dans une démarche EBP et en lien avec le pilier expertise, réactivez un maximum de vos connaissances.

Voici la demande initiale : **Monsieur JP Noël souffre d'un trouble bipolaire. Il se plaint de difficultés d'impulsivité et de difficultés de concentration.**

Dans le présent document, nous tentons de rassembler avec vous quelques éléments incontournables (et non exhaustifs) à explorer au regard de cette demande initiale.

I. Cours de Psychiatrie et Psychopharmacologie

Dans ce type de cours, l'étiologie, l'évaluation, et le traitement des troubles mentaux sont classiquement abordés. Étant donné la demande de Jean-Paul Noël, le diagnostic a déjà été posé. Il est toutefois indispensable d'être bien au clair avec la sémiologie (ensemble de signes et de symptômes) associée aux troubles bipolaires afin d'explorer et comprendre avec JP Noël ses possibles difficultés, et leurs impacts sur sa vie quotidienne !

L'âge de début du trouble bipolaire est traditionnellement entre 15 et 25 ans. On s'attend donc à une personne qui a rencontré des difficultés assez tôt dans sa vie d'adolescent ou de jeune adulte. Il sera donc important d'être sensible à l'impact de ses difficultés sur sa trajectoire de vie.

Sémiologie des troubles bipolaires

Comme vous le savez, les troubles bipolaires ne constituent pas une catégorie homogène. Différentes dimensions sont à explorer.

1) Le patient souffre-t-il de syndrome maniaque et hypomaniaque ?

Les symptômes du syndrome maniaque et hypomaniaque sont 1) les perturbations psychoaffectives (p. ex., humeur élevée, émotions versatiles et idées de grandeur) ; 2) les perturbations cognitives et psychomotrices (p. ex., accélération du cours de la pensée, fuites des idées, difficultés de concentration, accélération motrice et comportementale) ; 3) perturbations physiologiques (p. ex., insomnie, absence de sensation de fatigue, anorexie, augmentation du désir sexuel).

Le syndrome maniaque peut s'accompagner de symptômes psychotiques (hallucinations ; idées délirantes congruentes à l'humeur, souvent mégalomaniaques, mystiques ou prophétiques). Il s'accompagne fréquemment de comportements à risque (recherche de sensations fortes, la prise de toxiques, des conduites sexuelles à risque, des achats pathologiques/dépenses inconsidérées, etc.). Ces épisodes sont accompagnés d'une symptomatologie plus importante et d'un impact fonctionnel plus sévère que dans le syndrome hypomaniaque.

2) Le patient souffre-t-il de syndrome dépressif

Les symptômes du syndrome dépressif sont 1) les perturbations psychoaffectives (p. ex., humeur dépressive ; l'anhédonie ; le sentiment de culpabilité ; la perte de l'estime de soi, les idées suicidaires) ; 2) les perturbations cognitives et psychomotrices (p. ex., ralentissement psychomoteur et/ou agitation ; bradypsychie ; ruminations ; altérations cognitives ; bradykinésie ; hypomimie ; aprosodie ; aboulie) ; 3) perturbations physiologiques (p. ex., insomnie ; fatigue ; perte d'énergie ; perte ou hausse d'appétit ; diminution de l'excitation sexuelle, etc.).

3) Quelles sont l'évolution et la transition des épisodes ?

Il peut être important de connaître la récurrence et l'évolution des épisodes. Pour affiner le diagnostic si nécessaire, on peut alors être amené à questionner le nombre d'épisodes maniaques, hypomaniaques, et dépressifs. Savoir s'ils ont un caractère saisonnier ou s'ils sont liés à des facteurs de stress environnementaux (anniversaires traumatiques, etc.) ; savoir si les épisodes sont fréquents (les formes à cycles rapides - de plus de 4 épisodes toutes polarités confondues par an - sont plus pharmacorésistantes).

4) Quelles sont les comorbidités ?

Les troubles bipolaires sont régulièrement associés à d'autres problématiques telles que la prise de substances (alcool, cannabis, amphétamines et cocaïne, hallucinogènes). Un épisode maniaque ou dépressif peut faire être précipité par une prise initiale de substance. On peut également rechercher les autres comorbidités comme les troubles anxieux (trouble panique, les phobies sociales, les phobies simples) ; les troubles du sommeil et des rythmes ; un TDAH ; un trouble de la personnalité (personnalité état limite) ; un trouble obsessionnel-compulsif. On s'inquiétera de leurs impacts fonctionnels.

5) Doit-on se poser la question du diagnostic différentiel ?

Si le diagnostic n'est pas clairement établi, il est important de se poser aussi la question du diagnostic différentiel. La prise de substance est le diagnostic différentiel le plus fréquent. Si l'apparition est tardive (plus de 40 ans), il est nécessaire de s'inquiéter d'une éventuelle étiologie endocrinienne (hypo- et hyperthyroïdie), métabolique ou neurologique (p. ex., tumeur cérébrale, sclérose en plaques, accident vasculaire cérébral, un début de démence). Des troubles cognitifs progressifs pourraient nous inquiéter. En cas de doute, échanger avec le psychiatre ou le médecin traitant (avec l'accord du patient).

II. Cours de Neuropsychologie

Dans ce type de cours, l'étiologie, l'évaluation, et le traitement des troubles cognitifs sont classiquement abordés. Étant donné la demande, il semble que les difficultés cognitives soient problématiques pour JP Noël. Il est nécessaire d'être à l'écoute des difficultés attentionnelles et dysexécutives éventuelles. On sera également vigilant aux plaintes et aux signes de difficultés mnésiques, fréquentes dans les troubles de l'humeur.

6) Quelle est la nature du trouble attentionnel présenté par ce patient ?

Nous lisons dans la demande des difficultés de concentration. Deux composantes sont à prendre en compte : la sélectivité et l'intensité de l'attention. Des difficultés de concentration peuvent découler d'une problématique à ces deux niveaux. Le patient présente-t-il des difficultés d'attention soutenue ou de vigilance ? Pour répondre à cette question, nous écouterons s'il est capable de maintenir un niveau attentionnel suffisant pendant des périodes prolongées (avec peu ou beaucoup de stimulation). Pour répondre à la question d'un problème d'attention sélective, nous écouterons si le patient se plaint de distractibilité (par des pensées, du bruit, etc.).

7) Quelle est la nature du trouble des fonctions exécutives présenté par ce patient ?

Nous lisons dans la demande des difficultés d'impulsivité. Nous serons donc à l'écoute des éventuelles difficultés dysexécutives (et plus spécifiquement d'inhibition). Des difficultés d'inhibition peuvent s'exprimer par une grande distractibilité (la personne ne parvient pas à empêcher efficacement des

informations externes ou internes non pertinentes d'entrer en mémoire de travail) ou encore par des comportements verbaux ou non verbaux inadaptés (la personne ne parvient pas à empêcher la production automatique de réponses). On peut également entendre dans les plaintes un manque de flexibilité (par exemple, une difficulté à adopter une nouvelle stratégie ou un nouveau comportement lorsque les circonstances l'exigent), des phénomènes de persévération ou de rigidité comportementale. On peut également noter des difficultés de planification et de décision avec une forme d'impulsivité (la personne ne prend pas le temps d'analyser la situation et d'élaborer une réponse).

8) Le patient a-t-il d'autres troubles cognitifs ?

Nous pouvons également nous questionner sur les conséquences de ces difficultés sur d'autres domaines comme la mémoire épisodique qui peut s'exprimer par des plaintes d'oublis à mesure, mais également des difficultés de mémoire prospective (oublis d'action à effectuer). Les difficultés de mémoire sont fréquentes, car elles peuvent découler de difficultés d'encodage de stockage ou encore de récupération. L'ensemble de ces étapes peuvent être impactées par différents facteurs (p. ex., problème attentionnel/exécutif ; biais cognitifs, etc.).

III. Cours de Psychologie de la santé

Si vous avez suivi le cours d'Anne-Marie Etienne, celle-ci vous a invité à suivre le MOOC "Agir pour sa santé" dans lequel vous avez pu découvrir un grand nombre de notions. Nous allons nous concentrer ici sur la notion transversale de qualité de vie. Si nous nous intéressons aux difficultés du patient, c'est bien entendu toujours dans l'optique de nous questionner plus généralement sur leurs impacts sur la qualité de vie du patient.

9) Comment JP Noël définit-il sa qualité de vie ?

La définition de l'OMS de la qualité de vie est la suivante : « *La perception qu'a un individu de sa place dans l'existence dans le contexte de la culture et du système de valeurs dans lequel il vit, ceci en relation avec ses objectifs, ses attentes, ses principes et ses inquiétudes* ». Nous devons donc questionner ces éléments. Une variété de dimensions entre en jeu, bien évidemment, mais la qualité de vie ne peut être résumée comme la simple somme de celles-ci. Nous devons chercher quel est le moteur de JP Noël dans ses différentes activités, quels sont ses buts (organisés hiérarchiquement) et où faut-il réduire l'écart entre ce qu'il vit et ce qu'il aimerait vivre.